

Modules biologiques - Antiépileptiques

Antipsychotiques inclus | Surveillance ciblée, sans dosages thérapeutiques automatiques

Antiépileptiques - principe

- Ne pas programmer automatiquement une concentration plasmatique tous les 6 ou 12 mois chez tout patient stable.
- Dosage thérapeutique surtout utile si : contrôle insuffisant, toxicité suspectée, interaction, changement de dose/formulation, observance incertaine ou situation physiologique particulière.

Surveillance ciblée par traitement

Traitement	Surveillance utile	Dosage plasmatique
Valproate	Foie avant puis régulièrement les 6 premiers mois; hématologie/coagulation selon RCP et contexte.	Si contrôle insuffisant / EI / interaction.
Carbamazépine	Surveillance clinique; NFS si signes; foie; Na surtout sujet âgé/diurétiques/hyponatrémie.	Si besoin clinique / pharmacologique.
Phénobarbital	Foie/rein selon terrain; risque osseux à considérer au long cours.	Si suspicion de sur/sous-dosage, interaction, situation particulière.
Antipsychotiques	Poids/IMC, TA, glycémie/HbA1c, lipides; ECG selon molécule/risque; prolactine si symptômes.	Pas de dosage plasmatique de routine.

Mention si dosage antiépileptique

- Prélèvement au moment approprié (souvent résiduel), avec heure de dernière prise, posologie, galénique et motif du dosage.
- Valproate : hypoalbuminémie/IRC peuvent augmenter la fraction libre et rendre la concentration totale trompeuse.

Vitamine D et traitement antiépileptique

- Un risque osseux lié à un antiépileptique ne signifie pas automatiquement qu'un dosage 25-OH vitamine D est remboursé.
- Vérifier les 6 indications NABM ou qu'un RCP préconise explicitement le dosage.
- Sinon : prescription "NR".

Surveillance réglementaire reproductive

- Valproate et carbamazépine comportent en France des conditions renforcées de prescription/information pour certaines populations en âge de procréer.
- Vérifier le RCP et les documents de prévention de grossesse en vigueur. Ce point est réglementaire mais distinct du bilan biologique.